

PLANILHA COMPARATIVA — DOENÇAS DA POLPA E DO PERIÁPICE

Compare rapidamente dor, mobilidade, percussão, necrose, teste de vitalidade, radiografia e o achado-chave de cada uma das 20 entidades — organizado por categoria, para revisão de prova.

Como usar: cubra as colunas da direita com a mão e tente responder pelo nome da doença; ou cubra o nome e tente adivinhar a doença pelas características. As cores das linhas seguem a categoria (legenda abaixo).

- Alterações Pulpares
- Alterações Periapicais Agudas
- Alterações Periapicais Crônicas
- Complicações por Disseminação
- Osteomielites e Condições Ósseas Correlatas

ALTERAÇÕES PULPARES

Doença	Dor / sintoma inicial	Mobilidade	Percussão	Necrose	Teste de vitalidade	Radiografia	Característica-chave
Pulpite Reversível	Provocada, curta (frio/doce); cessa ao remover estímulo	Ausente	Ausente/negativa	Não	Positiva	Sem alteração (pode haver cárie visível)	Dor de curta duração ao frio, some rápido
Pulpite Irreversível	Espontânea, contínua, pulsátil; doi ao calor, alivia no frio	Ausente	Geralmente normal	Não (ainda vital)	Positiva (ou ausente em fase final)	Geralmente normal; pode alargar discretamente o LP apical	Dor espontânea/pulsátil; doi ao calor, alivia no frio
Pulpite Crônica Hiperplásica (Pólipo Pulpar)	Assintomática; sensível a mastigação	Ausente	Ausente	Não (tecido vital)	Positiva	Grande destruição coronária; ápice geralmente aberto	Massa avermelhada saindo do dente destruído
Necrose Pulpar	Assintomática ou variável	Ausente (geralmente)	Ausente inicialmente	Sim (total)	Negativa (nenhum teste)	Pode não mostrar alteração inicialmente	Sem resposta a nenhum teste de vitalidade
Calcificações Pulpares (Denticulos / Cálculos)	Assintomática	Ausente	Ausente	Não	Positiva (pode diminuir)	Radiopacidade puntiforme/nodular intrapulpar	Pontos radiopacos na polpa, assintomático

ALTERAÇÕES PERIAPICAIS AGUDAS

Doença	Dor / sintoma inicial	Mobilidade	Percussão	Necrose	Teste de vitalidade	Radiografia	Característica-chave
Periodontite Apical Aguda (Pericementite)	A percussão/oclusão; pode ocorrer em dente VITAL	Ausente/leve	Positiva, dolorosa	Variável (pode ser vital)	Negativa ou positiva retardada	Geralmente normal; discreto alargamento do LP	Dor a percussão/oclusão, pode ser dente vital
Abscesso Periapical Agudo	Intensa, espontânea, pulsátil	Presente (extrusão)	Extrema	Sim	Negativa	Pode ser normal ou radioluscentia mal definida	Dor intensa + extrusão + edema, pode ter febre

ALTERAÇÕES PERIAPICAIS CRÔNICAS

Doença	Dor / sintoma inicial	Mobilidade	Percussão	Necrose	Teste de vitalidade	Radiografia	Característica-chave
Granuloma Periapical (Periodontite Apical Crônica)	Assintomática	Ausente	Normal	Sim	Negativa	Radiolusência arredondada BEM definida	Radiolusência apical bem definida, assintomática
Cisto Radicular (Periapical)	Assintomática	Ausente (exceto lesões grandes)	Normal	Sim	Negativa	Radiolusência bem delimitada, pode ser extensa	Radiolusência apical bem definida, pode ser grande
Cisto Radicular Lateral	Assintomática	Ausente	Normal	Sim	Negativa	Radiolusência bem delimitada na LATERAL da raiz	Radiolusência na lateral da raiz
Cisto Residual	Assintomática	N/A (área edêntula)	N/A	N/A	N/A (sem dente associado)	Radiolusência bem delimitada em rebordo edêntulo	Radiolusência em área sem dente (pos-exodontia)
Abscesso Periapical Crônico	Assintomática (silenciosa)	Ausente	Normal	Sim	Negativa	Radiolusência SEM limites definidos	Radiolusência mal definida, silenciosa, +/- fístula

COMPLICAÇÕES POR DISSEMINAÇÃO

Doença	Dor / sintoma inicial	Mobilidade	Percussão	Necrose	Teste de vitalidade	Radiografia	Característica-chave
Celulite Facial	Difusa, quente, dolorosa	N/A (tecido mole)	Dente causador: negativa	Dente causador: sim	Dente causador: negativa	Depende do dente causador	Edema facial difuso, sem limite definido
Trombose do Seio Cavernoso	Ocular intensa + cefaleia	N/A	N/A	N/A	N/A	Não avaliada por periapical; requer TC/RM	Edema periorbitário bilateral, olho fixo/protruso
Angina de Ludwig	Cervical/assoalho bucal	N/A	N/A	N/A	N/A	Não e o foco diagnóstico inicial (emergência)	Tumefação bilateral do assoalho, língua elevada

OSTEOMIELITES E CONDIÇÕES ÓSSEAS CORRELATAS

Doença	Dor / sintoma inicial	Mobilidade	Percussão	Necrose	Teste de vitalidade	Radiografia	Característica-chave
Osteomielite Supurativa Aguda	Sensibilidade e tumefação	Pode haver	Variável	Óssea (espaços medulares)	Dente causador: negativa	Pode não revelar alteração inicial	Febre + leucocitose, evolução < 1 mês
Osteomielite Supurativa Crônica	Branda, com tumefação	Pode haver perda dentária	Variável	Óssea, com sequestro	Dente causador: negativa	Radioluscência mal definida + sequestros radiopacos	Fístula + sequestro ósseo, evolução > 1 mês
Osteíte Condensante	Indolor	Ausente	Normal	Não (reação óssea)	Dente causador alterado (pulpite/necrose)	Radiopacidade uniforme, SEM expansão	Radiopacidade uniforme no ápice, indolor
Osteomielite com Periostite Proliferativa (Garré)	Pouco dolorosa	Ausente	Normal	Não	Dente causador: variável	Laminações radiopacas paralelas ('casca de cebola')	Camadas radiopacas paralelas ('casca de cebola')
Osteíte Alveolar (Alvéolo Seco)	Intensa, 3-4 dias pos-exodontia	N/A	N/A	N/A (perda do coágulo, não infecção óssea)	N/A	Solicitada so para descartar fragmento/corpo estranho	Alvéolo vazio, osso exposto, odor fétido